



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
TIM *STUNTING* DAN *WASTING*
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**PROGRAM KERJA TIM STUNTING DAN WASTING
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara dikatakan berhasil jika memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Indonesia masih mengalami masalah yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikarenakan pemenuhan gizi sejak dalam kandungan hingga lahir masih belum tercukupi. Masalah gizi yang sedang Indonesia hadapi adalah *triple burden malnutrition* yaitu *wasting*, *stunting*, dan obesitas. Dari ketiga masalah gizi tersebut yang memiliki jumlah cukup tinggi dan berdampak pada bayi adalah *stunting* atau tubuh pendek.

Stunting atau pendek merupakan kondisi dimana bayi (0-11 bulan) dan balita (12-59 bulan) mengalami gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (WHO, 2014). Kekurangan gizi anak *stunting* juga dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, *stunting* baru nampak saat bayi berusia dua tahun (Yuliana dan Hakim, 2019). Kategori *stunting* dapat dilihat dengan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) atau panjang badan menurut umur (PB/U) dengan *z-score* < -3 SD sampai dengan < -2 SD (Kemenkes, 2020).

Masalah gizi *stunting* memiliki pengaruh jangka panjang pada tumbuh kembang balita yaitu dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, dan produktifitasnya di masa yang akan datang. Balita *stunting* cenderung akan sulit mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik secara fisik maupun psikomotorik (Aridiyah, 2015). Kondisi *stunting* juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap penyakit tidak menular. Berbagai studi membuktikan bahwa anak yang kurang gizi pada waktu balita dan kemudian mengalami *stunting*, maka pada usia dewasa akan lebih mudah mengalami obesitas dan terserang diabetes mellitus (Yuliana dan Hakim, 2019).

Prevalensi *stunting* di dunia diperkirakan sebesar 22,3% atau sekitar 148 juta balita mengalami *stunting* berdasarkan estimasi bersama lembaga internasional terbaru (WHO, UNICEF, World Bank, 2023). Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi *stunting* masih bervariasi antar negara, dimana Indonesia termasuk negara dengan beban *stunting* relatif tinggi dibanding beberapa negara lain meskipun prevalensi balita *stunting* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 dan sekitar 21,5% pada tahun 2023 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Selain itu, proporsi balita sangat pendek dan pendek secara nasional juga menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan periode sebelumnya, meskipun masih terdapat disparitas antar wilayah sehingga upaya percepatan penurunan *stunting* tetap menjadi prioritas program kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2023; WHO, 2023).

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh balita, namun juga berasal dari ibu hamil. Salah satu penyebab *stunting* adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan yaitu sejak janin hingga bayi usia dua tahun (TNP2K, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beal, dkk. (2018), faktor penyebab *stunting* di Indonesia berdasarkan faktor ibu yaitu asupan yang tidak adekuat selama pra-konsepsi, kehamilan, dan



menyusui, perawakan ibu pendek, kehamilan pada usia remaja, IUGR serta kelahiran prematur.

Wasting adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang mencerminkan berat badan anak terlalu kurus menurut tinggi badannya, ditandai dengan z-score BB/TB kurang dari -2 SD untuk *wasting* dan z-score BB/TB kurang dari -3 SD untuk severe wasting (Menteri Kesehatan RI, 2020).

Wasting pada anak-anak merupakan hasil dari penurunan berat badan yang cepat atau ketidakmampuan menambah berat badan (Unicef/ WHO/The World Bank, 2019). *Wasting* mengakibatkan balita berisiko mengalami ketertinggalan tumbuh kembang secara jangka panjang, penurunan fungsi sistem imunitas, peningkatan keparahan dan kerentanan terhadap penyakit menular, serta peningkatan risiko kematian terutama balita yang mengalami severe wasting (UNICEF/ WHO/The World Bank, 2019). Tumbuh kembang yang terjadi saat balita akan berdampak pada individu di masa yang selanjutnya. Jika anak mengalami ketidaksesuaian atau kegagalan tumbuh kembang, tidak teridentifikasi dan tidak mendapat tindakan yang baik, maka anak tidak dapat mencapai pertumbuhan yang maksimal. Hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kualitas generasi penerus bangsa di masa depan (Menteri Kesehatan RI, 2014).

Kekurangan gizi termasuk *wasting* dipengaruhi oleh faktor langsung, salah satunya ialah asupan makanan yang tidak adekuat (UNICEF, 2015). Zat gizi yang diperoleh tubuh dari asupan makan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan memelihara kesehatan (Hendrayati, Amir and Darmawati, 2013). Tingkat asupan zat gizi makro yakni energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang tidak adekuat terhadap kebutuhan tubuh, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan perubahan jaringan dan massa tubuh, yang selanjutnya berefek pada penurunan berat badan (Barasi, 2007).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;



13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 953.4/RSPHS/I/KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
14. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* disusun sebagai pedoman operasional bagi rumah sakit dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelayanan pencegahan serta penatalaksanaan *stunting* dan/atau *wasting* secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis bukti. Program kerja ini menjadi acuan bagi tim multidisiplin dalam memberikan pelayanan yang bermutu, aman, efektif, dan berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, standar keselamatan pasien, serta ketentuan akreditasi rumah sakit.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan pelayanan *stunting* dan *wasting* yang terkoordinasi dan berkualitas melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan status gizi pasien, menurunkan risiko komplikasi, serta mendukung pencapaian target program prioritas nasional di rumah sakit.

3. Tujuan Khusus

- a. Menyediakan pedoman kerja yang sistematis dan terstandar bagi tim multidisiplin dalam melaksanakan skrining, deteksi dini, asesmen komprehensif, diagnosis, intervensi, serta tindak lanjut kasus *stunting* dan/atau *wasting*.
- b. Memastikan pelaksanaan skrining gizi awal secara menyeluruh pada kelompok berisiko tinggi, meliputi balita (0 – 59 bulan) dan ibu hamil, sesuai standar praktik klinis dan pedoman nasional.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar profesi (dokter, ahli gizi, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya) dalam penatalaksanaan kasus secara terpadu dan berkesinambungan.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan *stunting* dan *wasting* agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan medik.
- e. Meningkatkan edukasi, komunikasi, dan konseling gizi kepada pasien dan keluarga untuk mendukung perubahan perilaku dan keberhasilan terapi.
- f. Menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara berkesinambungan sebagai bagian dari peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

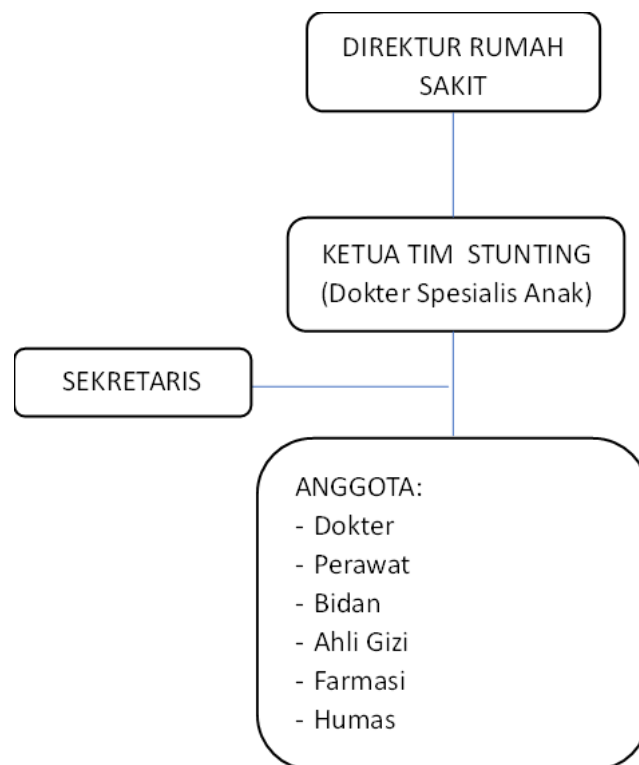
2.3 Motto

Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Kerjasama
5. Adil
6. Peduli

2.5 SOTK



Bagan 1. SOTK Tim Pelayanan Stunting dan Wasting

BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 SDM

3.1.1 Ketenagaan

Ketua	: dr. Ratih Kusumawardani, Sp.An., M.Biomed
Sekretaris	: Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz.
Anggota	:
Staff Medis	: dr. Achmad Fauzan Ailani
Staff Keperawatan	: Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns.
Staff Kebidanan	: Iin Widowati, S.Tr.Keb.
Staff Instalasi Gizi	: Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz.
Staff Instalasi Farmasi	: Shinta Aprilia Rizky Wulandari, S.Farm., Apt.
Anggota Tim Humas	: Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes.

3.1.2 Orientasi

Orientasi dilakukan kepada anggota baru dengan diberikan penjelasan mengenai jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan

Saat ini Prognas *Stunting* dan *Wasting* ada 8 orang dengan tingkat Pendidikan:

- a) S2 = 1 orang
- b) S1 = 3 orang
- c) D4 = 3 orang
- d) D3 = 1 orang

Belum ada pelatihan eksternal *stunting* dan *wasting*. Pelatihan Internal Stunting diselenggarakan di RS Prima Husada.

3.2 Kegiatan Pelayanan

No.	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Melakukan pemantauan kinerja SDM tim stunting dan wasting	Melakukan supervisi kepatuhan tim stunting dan wasting sesuai uraian tugas masing-masing
2.	Melakukan revisi regulasi pelayanan stunting dan wasting	1) Melakukan review regulasi yang berlaku di program stunting dan wasting 2) Merevisi pedoman pelayanan stunting dan wasting 3) Merevisi pedoman kerja tim stunting dan wasting 4) Membuat program pelayanan stunting dan wasting 5) Membuat program kerja tim stunting dan wasting
3.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting	1) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting di rawat jalan 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting di rawat inap 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting yang sudah di PRB.

3.3 Sasaran

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Melakukan pemantaun kinerja SDM tim stunting dan wasting	Menilai/mengukur kinerja SDM tim stunting dan wasting sesuai uraian tugas masing-masing	Tim stunting dan wasting: a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Internal tim stunting dan wasting	Sesuai uraian tugas masing-masing	Penilaian kinerja staff tim stunting dan wasting	
2.	Melakukan revisi regulasi pelayanan stunting dan wasting						
	1) Melakukan review regulasi yang berlaku di program stunting dan wasting	Melakukan review pedoman, program stunting dan wasting sesuai peraturan perundang yang terupdate	(1) pedoman pelayanan stunting dan wasting RS (2) pedoman kerja tim stunting dan wasting RS (3) program pelayanan stunting dan wasting RS tahun 2026 (4) program kerja tim stunting dan wasting RS tahun 2026	Review regulasi	100%	Ada bukti telah dilakukan review pada: (1) pedoman pelayanan stunting dan wasting RS (2) pedoman kerja tim stunting dan wasting RS Ada bukti telah dilakukan telaah pada: (3) program pelayanan stunting dan wasting RS tahun 2025 (4) program kerja tim stunting dan wasting RS tahun 2025	
	2) Merevisi pedoman pelayanan stunting dan wasting	Melakukan revisi pedoman pelayanan stunting dan wasting sesuai peraturan	pedoman pelayanan stunting dan wasting RS	Review, perbaikan	100%	Tersedianya dokumen pedoman pelayanan stunting dan wasting yang telah direvisi,	



		perundang yang terupdate				disahkan, dan diberlakukan di rumah sakit	
	3) Merevisi pedoman kerja tim stunting dan wasting	Melakukan revisi pedoman kerja tim stunting dan wasting sesuai peraturan perundang yang terupdate	pedoman kerja tim stunting dan wasting RS	Review, perbaikan	100%	Tersedianya dokumen pedoman pelayanan stunting dan wasting yang telah direvisi, disahkan, dan diberlakukan di rumah sakit	
	4) Membuat program pelayanan stunting dan wasting	Melakukan penyusunan program pelayanan stunting dan wasting	Program pelayanan stunting dan wasting tahun 2026	Perencanaan	100%	Tersedianya dokumen program pelayanan stunting dan wasting tahun 2026 yang telah disusun, disahkan, dan menjadi acuan pelaksanaan pelayanan	
	5) Membuat program kerja tim stunting dan wasting	Melakukan penyusunan program kerja tim stunting dan wasting	Program kerja tim stunting dan wasting tahun 2026	Perencanaan	100%	Tersedianya dokumen program kerja tim stunting dan wasting tahun 2026 yang telah disusun, disahkan, dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tim	
3.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting						
	1) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting di rawat	Mengetahui capaian pelaksanaan program serta sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan stunting dan	Kegiatan pelayanan stunting dan wasting di rawat jalan	Monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai standar pelayanan dan program nasional	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program stunting dan wasting secara berkala yang	



	jalan	wasting secara berkelanjutan di rawat jalan			percepatan penurunan stunting	terdokumentasi (umandok) serta digunakan sebagai dasar tindak lanjut/perbaikan program	
	2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting di rawat inap.	Mengetahui capaian pelaksanaan program serta sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan stunting dan wasting secara berkelanjutan di rawat inap	Kegiatan pelayanan stunting dan wasting di rawat inap	Monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai standar pelayanan dan program nasional percepatan penurunan stunting	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program stunting dan wasting secara berkala yang terdokumentasi (umandok) serta digunakan sebagai dasar tindak lanjut/perbaikan program	
	3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting yang sudah di PRB	Menilai keberlanjutan pelayanan serta efektivitas tindak lanjut pasien stunting dan wasting pasca rujukan balik (PRB)	Pasien stunting dan wasting yang telah dikembalikan ke FKTP (PRB), tim stunting dan wasting, serta jejaring rujuka	Monitoring dan evaluasi	Sesuai standar pelayanan rujukan balik, pedoman tatalaksana stunting dan wasting, serta regulasi program nasional	Sesuai standar pelayanan rujukan balik, pedoman tatalaksana stunting dan wasting, serta regulasi program nasional	



3.4 Cara melaksanakan Kegiatan

NO	KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Melakukan pemantaun kinerja SDM tim stunting dan wasting	1) Membuat form penilaian kinerja setiap SDM tim stunting dan wasting 2) Melakukan penilaian	Observasi, checklist	spreadsheet	1 tahun 1x	Terdapat penilaian kinerja setiap SDM tim stunting dan wasting	
2.	Melakukan revisi regulasi pelayanan stunting dan wasting						
	1) Melakukan review regulasi yang berlaku di program stunting dan wasting	Melakukan rapat tim stunting dan wasting: a. Membuat undangan b. Melaksanakan rapat c. Mengisi daftar hadir d. Membuat notulen e. Mendokumentasikan kegiatan (Umandok)	Rapat	Laptop, LCD, Proyektor, mic	Setiap ada perubahan regulasi dari pemerintah terkait stunting dan wasting	umandok	
	2) Merevisi pedoman pelayanan stunting dan wasting	a. Melakukan kajian pada pedoman sebelumnya b. Menyusun revisi c. Melakukan rapat pembahasan hasil revisi d. Pengesahan	Rapat, review dokumen	Laptop, pedoman, referensi regulasi, LCD	Setiap ada pembaruan/1 tahun 1x	Dokumen pedoman pelayanan stunting dan wasting yang telah direvisi	
	3) Merevisi pedoman kerja tim stunting dan wasting	a. Meninjau tugas dan fungsi tim b. Menyusun revisi c. Melakukan rapat pembahasan hasil revisi d. Pengesahan	Rapat, review dokumen	Laptop, dokumen, LCD	Setiap ada pembaruan/1 tahun 1x	Dokumen pedoman kerja tim stunting dan wasting yang telah direvisi	
	4) Membuat program pelayanan stunting dan wasting	a. Mengidentifikasi kebutuhan b. Menyusun rencana program pelayanan c. Menetapkan indikator dan	Perencanaan, rapat	Laptop, format program, LCD	1 tahun 1x	Dokumen program pelayanan stunting dan wasting	



NO	KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		target d. Menetapkan kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan e. Koordinasi lintas unit					
	5) Membuat program kerja tim stunting dan wasting	a. Menyusun rencana kerja tahunan b. Menetapkan indikator dan target c. Menetapkan kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan d. Koordinasi tim	Perencanaan, rapat	Laptop, format program, LCD	1 tahun 1x	Dokumen program kerja tim stunting dan wasting	
3.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting						
	1) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting di rawat jalan	a. Melakukan analisis capaian indikator pelayanan stunting dan wasting di rawat jalan b. Melaksanakan rapat evaluasi tim c. Menyusun laporan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut	Monitoring dan evaluasi	Laptop, laporan	Triwulan	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi hasil pemantauan pelayanan stunting dan wasting di rawat jalan	
	2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting di rawat inap.	a. Melakukan analisis capaian indikator pelayanan stunting dan wasting di rawat inap b. Melaksanakan rapat evaluasi tim c. Menyusun laporan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut	Monitoring dan evaluasi	Laptop, laporan	Triwulan	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi hasil pemantauan pelayanan stunting dan wasting di rawat inap	
	3) Melakukan pemantauan	a. Mengidentifikasi pasien yang	Koordinasi,	Laptop, laporan	Sesuai pelayanan	Tersedia laporan	



NO	KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting yang sudah di PRB	telah dilakukan rujukan balik (PRB) b. Melakukan koordinasi dengan FKTP terkait tindak lanjut pasien c. Melakukan follow up status pasien (kunjungan/telepon) d. Melakukan evaluasi keberlanjutan pelayanan	monitoring dan evaluasi			monitoring dan evaluasi hasil pemantauan pelayanan stunting dan wasting yang sudah di PRB	



3.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	Pelaksana	Sumber Dana	Metode
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Melakukan pemantaun kinerja SDM tim stunting dan wasting	Tim stunting dan wasting: a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota												√	Rumah Sakit Prima Husada	Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Observasi, checklist
2.	Melakukan revisi regulasi pelayanan stunting dan wasting																	
	1) Melakukan review regulasi yang berlaku di program stunting dan wasting	(1)pedoman pelayanan stunting dan wasting RS (2)pedoman kerja tim stunting dan wasting RS (3)program pelayanan stunting dan wasting RS tahun 2026 (4)program kerja tim stunting dan wasting RS tahun 2026											√		Rumah Sakit Prima Husada	Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Rapat
	2) Merevisi pedoman pelayanan stunting dan wasting	pedoman pelayanan stunting dan wasting RS											√		Rumah Sakit Prima Husada	Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Rapat, review dokumen
	3) Merevisi pedoman kerja tim stunting dan wasting	pedoman kerja tim stunting dan wasting RS											√		Rumah Sakit Prima Husada	Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Rapat, review dokumen
	4) Membuat program pelayanan	Program pelayanan stunting dan wasting tahun 2026											√		Rumah Sakit Prima Husada	Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Perencanaan, rapat



No.	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	Pelaksana	Sumber Dana	Metode
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	stunting dan wasting														Husada			
	5) Membuat program kerja tim stunting dan wasting	Program kerja tim stunting dan wasting tahun 2026											√		Rumah Sakit Prima Husada	Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Perencanaan, rapat
3.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting																	
	1) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting di rawat jalan	Kegiatan pelayanan stunting dan wasting di rawat jalan			√			√			√			√	Rawat jalan	1. Unit terkait 2. Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Monitoring dan evaluasi
	2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting di rawat inap.	Kegiatan pelayanan stunting dan wasting di rawat inap			√			√			√			√	Rawat inap	1. Unit terkait 2. Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Monitoring dan evaluasi
	3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting yang sudah di PRB	Pasien stunting dan wasting yang telah dikembalikan ke FKTP (PRB), tim stunting dan wasting, serta jejaring rujukan														Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Rumah Sakit Prima Husada	Koordinasi, monitoring dan evaluasi

3.6 Kebutuhan Anggaran

No.	Uraian	Kebutuhan	Harga @	Jumlah
1	Pelatihan eksternal tim stunting	4 orang	Rp. 1.000.000	Rp. 4.000.000
2	Pelatihan internal tim stunting	8 orang	-	-
3	Pengajuan penambahan alat pengukuran antropometri: 1. Infatometer 2. Baby scale 3. Microtoice 4. Pita LiLA 5. Metlin			Rp. 2.000.000 Rp. 500.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000 Rp. 90.000
4	Leaflet	1 rim	Rp. 100.000	Rp. 100.000
TOTAL				Rp. 7.780.000



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring

1. Melakukan supervisi pelaksanaan tugas anggota tim sesuai uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Melakukan penelusuran dokumen regulasi yang berlaku dan kebutuhan revisi sesuai perkembangan regulasi terbaru.
3. Memantau pelaksanaan pelayanan stunting dan wasting di rawat jalan dan rawat inap.

4.2 Evaluasi

1. Menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan tugas, ketercapaian target kerja, dan kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program.
2. Menilai kelengkapan, kesesuaian, dan implementasi regulasi yang telah direvisi atau disusun.
3. Menganalisis capaian indikator program, mutu pelayanan, kepatuhan pelaksanaan pelayanan, serta tindak lanjut kasus.



BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 Pencatatan

Semua kegiatan pelayanan *stunting* dan *wasting* dicatat sesuai jenis kegiatan dan SPO.

5.2 Pelaporan

Laporan disusun berdasarkan laporan dari unit kerja setiap bulan, triwulan, dan tahunan, serta tim *stunting* dan *wasting* melaporkan kegiatan ke Direktur.

1. Laporan Bulanan

Laporan dibuat setiap bulan untuk pelaporan kegiatan pelayanan mutu serta jumlah stok alat kontrasepsi.

2. Laporan Triwulan

Laporan dibuat dengan merekap hasil kinerja selama 3 bulan.

3. Laporan Tahunan

Laporan dibuat 1 tahun sekali pada akhir tahun dan diserahkan pada awal bulan Januari tahun berikutnya.



BAB VI PENUTUP

Program Kerja Tim Pelayanan Stunting dan Wasting ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan masalah gizi secara terintegrasi di rumah sakit. Diharapkan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkesinambungan guna mendukung peningkatan mutu pelayanan serta berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting dan wasting. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan agar program berjalan efektif dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
PLT. Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

Pasuruan, 1 November 2025
Ketua Tim *Stunting*

dr. Ratih Kusumawardani, Sp.An., M.Biomed